carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Antiparkinsonianos

SEMANA 11

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

"Nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que nos caemos"

Confucio

Artículo científico: **La orientación familiar para la rehabilitación físico-terapéutica de pacientes con Parkinson**

Revista RIAF ISSN: 2953-6693 Vol. – 3 No. 1, enero 2025

Artículos

La orientación familiar para la rehabilitación físico-terapéutica de pacientes con Parkinson

Family guidance for the physical-therapeutic rehabilitation of patients with Parkinson's

Dra. Denia Pérez Pérez [1]; Dr. C. Esteban Juan Pérez Hernández [2] & Maria Karla Marrero Pérez [3]

RIAF. Revista Internacional de Actividad Física
Universidad de Guayaquil, Ecuador
Periodicidad: Semestral
Vol. 3, núm. 1, 2025
revista.riaf@ug.edu.ec

DOI: https://doi.org/10.53591/riaf.v3i1.1860

Recepción: 24 de octubre de 2024
Aprobación: 28 de noviembre de 2024

URL: https://revistas.ug.edu.ec/index.php/riaf
DOI: https://doi.org/10.53591/riaf.v3i1.1860

Resumen: La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, afecta el sistema nervioso central y la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial para el movimiento. Este artículo tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura acerca de la Orientación Familiar para la rehabilitación en los pacientes con Parkinson, pues el apoyo familiar tiene gran importancia en la vida de estas personas. Se desarrolló un estudio de enfoque cualitativo, realizando una búsqueda del material bibliográfico generado en los últimos 5 años, utilizando las bases de datos de PudMed, Scielo y Dialnet entre otras, recopilando 28 referencias bibliográficas. Las investigaciones sobre la orientación familiar se centran en su interés en la participación activa de la familia en el cuidado y apoyo del paciente con Parkinson en la rehabilitación terapéutica. Se destaca la necesidad de un mayor número de estudios que incluyan a la familia como un pilar fundamental para estas personas. Esta investigación analizó cuatro aspectos clave: una descripción general de la enfermedad de Parkinson y sus síntomas, las intervenciones fisioterapéuticas para mejorar la funcionalidad del paciente, el papel crucial de la familia en la rehabilitación y la orientación familiar, incluyendo su definición, recursos y estrategias de apoyo.

Palabras claves: Enfermedad de Parkinson; rehabilitación; orientación familiar

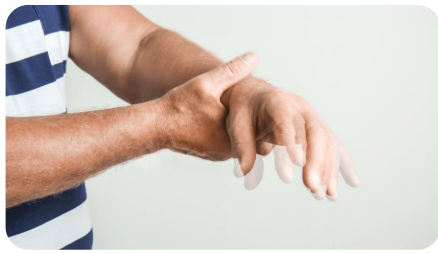
La Enfermedad de Parkinson y su Prevención - YouTube

Al finalizar la sesión, el estudiante explica la acción y efecto farmacológico de los fármacos antiparkinsonianos, luego de ver el video

1. Clasificación
2. Acción farmacológica
3. Usos terapéuticos
4. Contraindicaciones
5. Reacciones Adversas

¿Qué es el Parkinson?

La enfermedad de Parkinson consiste en un **desorden crónico y degenerativo** de una de las partes del cerebro que controla el sistema motor y se manifiesta con una **pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos, entre otros síntomas**.
Se produce cuando las células nerviosas de la sustancia negra del mesencéfalo, área cerebral que controla el movimiento, mueren o sufren algún deterioro.



Síntomas

- Los primeros síntomas son leves y se van haciendo cada vez mas notorio con el paso del tiempo.
- El cuadro inicial típico registra dolores en las articulaciones, dificultades para realizar movimientos y agotamiento.

Síntomas típicos:

- **Temblor:** movimiento rítmico hacia atrás y adelante, generalmente comienza en la mano
- **Rigidez:** falta de flexibilidad muscular y debilidad
- **Bradicinesia:** perdida de movimiento espontaneo y automático y conlleva la lentitud en todas las acciones.
- **Inestabilidad:** inestabilidad de la postura , inclinación hacia adelante o hacia atrás y se caen con facilidad.

Fármacos antiparkinsonianos

- **Depresión**: es un problema común, en el Parkinson puede detectarse antes de que comience los síntomas principales.
- **Dificultad para tragar y masticar:** el mal funcionamiento de los músculos dificulta esta tarea cotidiana, favoreciendo la acumulación de saliva y alimentos en la cavidad bucal.
- **Problemas urinarios:** incontinencia o dificultades para orinar.
- Estreñimiento: por lentitud en los músculos intestinales.
- **Trastornos de sueño:** somnolencia o pesadillas son características.
- **Perdida de la expresividad:** el rostro pierde expresividad y aparece la denominada cara de pez o mascara por falta de expresión de los músculos de la cara.
- **Aumento o perdida de peso:** por la propia enfermedad o por los medicamentos.
- **Hispomia:** mala distinción de los olores o la reducción de la capacidad para percibirlos.

- **Los temblores**, aunque no todos los pacientes los experimentan, los temblores en reposo son un síntoma característico, afectando principalmente las manos, brazos, piernas y mandíbula.
- La **rigidez muscular** donde los músculos se vuelven rígidos y difíciles de mover, lo que limita la flexibilidad y el rango de movimiento.
- La **bradicinesia** (lentitud de movimiento), las acciones cotidianas como caminar, vestirse o escribir se vuelven más lentas y laboriosas.
- Los **problemas de equilibrio y coordinación**: El riesgo de caídas aumenta debido a la inestabilidad postural.

- Son la **fatiga y dolor**. La enfermedad puede causar **cansancio persistente y dolores musculares o articulares**.
- Los cambios químicos en el cerebro y los desafíos de vivir con la enfermedad pueden afectar la salud mental con **depresión y ansiedad.**
- El **insomnio**, **las pesadillas y los trastornos del sueño** son comunes.
- En etapas avanzadas, pueden surgir **dificultades con la memoria, la atención y el pensamiento**

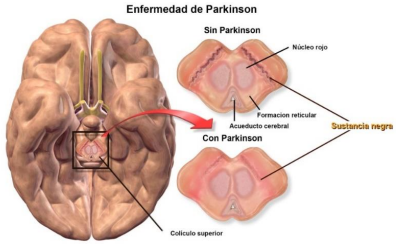
https://m.facebook.com/VictorGordoMD/photos/a.1857749234498445/2474030982870264/?type=3&locale2=zh_CN

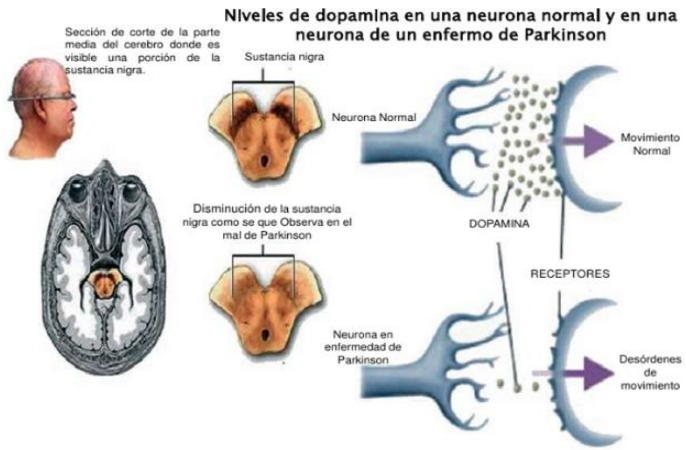
Fármacos antiparkinsonianos

Los fármacos antiparkinsonianos son drogas de utilidad terapéutica en la enfermedad del Parkinson.

Como ya se ha comentado, la lesión fundamental en la enfermedad de Parkinson consiste en una degeneración de la vía dopaminérgica.

La hipofunción dopaminérgica es responsable de los síntomas característicos de la enfermedad, que son el temblor, la rigidez, la acinesia y las alteraciones posturales.



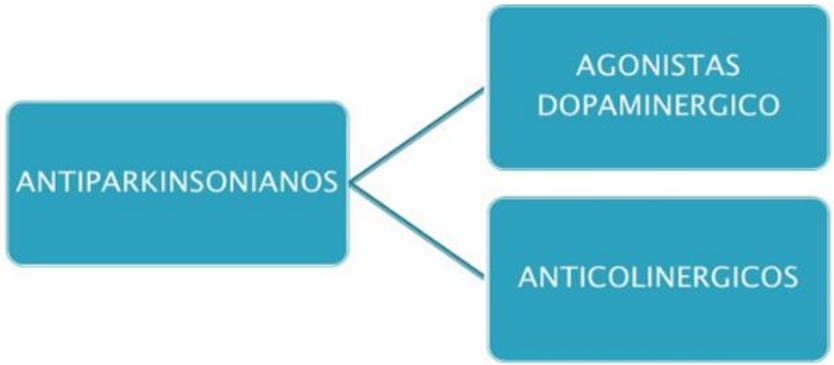


https://twitter.com/biologiayarte/status/1242759128482631681

La disminución de dopamina ocasiona una alteración de todos los músculos del cuerpo, no solo de los músculos de brazo y piernas, sino también de los empleados para comer, hablar, escribir, etc. Es por ello que los síntomas principales de la enfermedad de Parkinson afectan al sistema motor.

El Parkinson se manifiesta por cuatro síntomas fundamentales: **temblor, rigidez muscular, acinesia (disminución de los movimientos voluntarios) y trastornos de la marcha.**

Clasificación:



Clasificación:

Agonistas dopaminérgicos

- ✓ Levodopa+carbidopa
- ✓ Pergolida
- ✓ Selegilina
- ✓ Tolcapona

Anticolinérgicos

- ✓ Biperideno
- ✓ Trihexifenidilo

1. PRECURSORES DE DOPAMINA + INHIBIDORES DE LA DESCARBOXILASA
–Levodopa(L-dopa) + Benserazida
–Levodopa+ Carbidopa

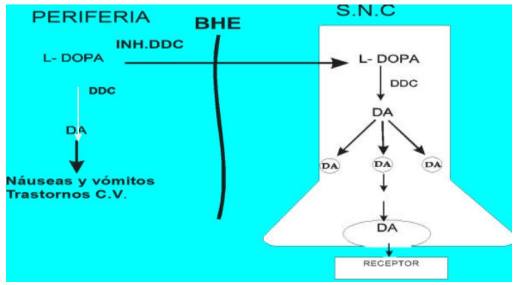
2. ANTICOLINERGICOS ANTIPARKINSONIANOS
–Biperideno
–Trihexifenidilo.

3. INHIBIDORES DE LA MONOAMINO-OXIDASA -β-SELECTIVOS (I.M.A.O-β)
–Selegilina

4. INHIBIDORES DE LA CATECOL-ORTO-METIL-TRANSFERASA (I.C.O.M.T)
–Entacapona
–Tolcapona

1) PRECURSORES DE DOPAMINA + INHIBIDORES DE DESCARBOXILASA

- En el gráfico se observa la formación de dopamina (DA) a partir de L-DOPA en la periferia y en el SNC.
- La L-DOPA, por la acción de la dopa-descarboxilasa (DDC) da lugar en la periferia a DA que produce efectos secundarios.
- En presencia de inhibidor de la DDC, que no cruza la barrer hematoencefálica(BHE), pasa al cerebro una mayor cantidad de L-DOPA, que se incorpora a las neuronas dopaminérgicas, produciéndose una acción de reemplazo.



2) ANTICOLINERGICOS ANTIPARKINSONIANOS

- Actúan bloqueando receptores muscarínicos, inhibiendo la acción de la acetilcolina. De esta manera se facilita la acción de la dopamina.

3) INHIBIDORES DE LA MONOAMINO-OXIDASA -β-SELECTIVOS (IMAO-β)

- Inhiben a la enzima monoamino-oxidasa-β, de tal manera que se disminuye el catabolismo de la dopamina.

4) INHIBIDORES DE LA CATECOL-ORTOMETILTRANSFERASA (ICOMT)

- Inhiben a la enzima catecol-orto-metil-transferasaque normalmente catabolizaa la dopamina y la levodopa.

1. PRECURSORES DE DOPAMINA + INHIBIDORES DE DESCARBOXILASA.

- Enfermedad de Parkinson. Parkinsonismo sintomático, posencefálico, tóxico o arteriosclerótico, excepto el síndrome parkinsoniano de origen medicamentoso.

2) INDICACIONES TERAPÉUTICAS ANTICOLINÉRGICOS ANTIPARKINSONIANOS

- Tratamiento del parkinsonismo en todas sus formas posencefalico, arteriosclerótico o idiopático).
- Tratamiento de las reacciones extrapiramidales inducidas por fármacos.

3) INHIBIDORES DE LA MONOAMINO OXIDASA SELECTIVOS (I.M.A.O)

- Como coadyuvante de la levodopa carbidopa, en pacientes con poca respuesta a dicha asociación.

4) INHIBIDORES DE LA CATECOL ORTO METIL TRANSFERASA (I.C.O.M.T)

- Coadyuvante de la levodopa/ carbidopa y de la levodopa/ benserazida

1) PRECURSORES DE DOPAMINA + INHIBIDORES DE DESCARBOXILASA

- Intolerancia digestiva, arritmias cardiacas e hipotensión ortostática

2) ANTICOLINERGICOS ANTIPARKINSONIANOS

- Sequedad de boca, visión borrosa, constipación, retención urinaria, aumento de presión intraocular, somnolencia y rash cutáneo.

3) INHIBIDORES DE LA MONOAMINO OXIDASA SELECTIVOS (I.M.A.O)

- Trastornos GI, confusión, alucinaciones, boca seca, etc.

4) INHIBIDORES DE LA CATECOL ORTO METIL TRANSFERASA (I.C.O.M.T)

- Trastornos GI.

Revista RIAF ISSN: 2953-6693 Vol. – 3 No. 1, enero 2025

Artículos

La orientación familiar para la rehabilitación físico-terapéutica de pacientes con Parkinson

Family guidance for the physical-therapeutic rehabilitation of patients with Parkinson's

Dra. Denia Pérez Pérez [1]; Dr. C. Esteban Juan Pérez Hernández [2] & Maria Karla Marrero Pérez [3]

RIAF. Revista Internacional de Actividad Física
Universidad de Guayaquil, Ecuador
Periodicidad: Semestral
Vol. 3, núm. 1, 2025
revista.riaf@ug.edu.ec

DOI: https://doi.org/10.53591/riaf.v3i1.1860

Recepción: 24 de octubre de 2024
Aprobación: 28 de noviembre de 2024

URL: https://revistas.ug.edu.ec/index.php/riaf
DOI: https://doi.org/10.53591/riaf.v3i1.1860

Resumen: La enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común, afecta el sistema nervioso central y la producción de dopamina, un neurotransmisor esencial para el movimiento. Este artículo tiene como objetivo realizar una revisión de la literatura acerca de la Orientación Familiar para la rehabilitación en los pacientes con Parkinson, pues el apoyo familiar tiene gran importancia en la vida de estas personas. Se desarrolló un estudio de enfoque cualitativo, realizando una búsqueda del material bibliográfico generado en los últimos 5 años, utilizando las bases de datos de PudMed, Scielo y Dialnet entre otras, recopilando 28 referencias bibliográficas. Las investigaciones sobre la orientación familiar se centran en su interés en la participación activa de la familia en el cuidado y apoyo del paciente con Parkinson en la rehabilitación terapéutica. Se destaca la necesidad de un mayor número de estudios que incluyan a la familia como un pilar fundamental para estas personas. Esta investigación analizó cuatro aspectos clave: una descripción general de la enfermedad de Parkinson y sus síntomas, las intervenciones fisioterapéuticas para mejorar la funcionalidad del paciente, el papel crucial de la familia en la rehabilitación y la orientación familiar, incluyendo su definición, recursos y estrategias de apoyo.

Palabras claves: Enfermedad de Parkinson; rehabilitación; orientación familiar

Consultas

- Flores J. Farmacología humana. 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. Farmacología básica y clínica. 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J. **Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.